Processo nº **0022119-13.2023.8.17.2810**

AUTOR(A): ERICLEIDE GUEDES LIMA DA SILVA

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Vistos etc.

ERICLEIDE GUEDES LIMA DA SILVA, parte autora qualificada nos autos, por intermédio de advogado legalmente constituído, ajuizou a presente "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR" em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, parte ré igualmente identificada.

Alegou a parte autora, em sua petição inicial, que:

A) já ciente de seu quadro de diabetes, recebeu o triste diagnóstico de câncer de mama no ano de 2020, submetendo-se à cirurgia e radioterapia, seguida de ministração de bloqueadores hormonais (ácido de Goserelina e Anastrozol) para manutenção do quadro de saúde. Tais medicamentos sem previsão para desmame e suspensão de uso;

B) após o início do tratamento com os bloqueadores hormonais, como efeito colateral, a autora sofreu com grande ganho de peso, influenciando, inclusive, na circulação sanguínea de seu braço direito, passando a sofrer com episódios de dormência do membro;

C) mesmo com dieta hipocalórica na sua rotina e praticando exercícios regulares, o quadro de sobrepeso não foi alterado;

D) a endocrinologista da demandante prescreveu, então, medicamento de alto custo: semaglutida na dosagem gradativa e crescente de 0,25 mg até 1mg, por entender ser o melhor tratamento no momento para perda de peso sem que interfira no carcinoma de mama e no diabetes;

E) ocorre que, a SUL AMÉRICA negou o fornecimento do fármaco, como consta na Guia n. 00624620230308063661, sob o argumento de que a solicitação não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

F) o tratamento deve ser iniciado o quanto antes e o remédio prescrito na menor cotação1, custa R$ 949,90.

Pugnou pela tutela antecipada para determinar que forneça o medicamento indicado por laudo médico. Ao final, requereu a total procedência da demanda, condenação em obrigação de fazer, sob pena de conversão em perdas e danos, no importe de R$ 24.000,00 e a condenação em indenização dos danos morais ocasionados e 37.537,45.

Atribuiu à causa o valor de R$ 61.537,45. Pugnou pela gratuidade da Justiça.

Decisão de ID 132314963, deferiu a gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Citada, a ré apresentou contestação (ID 136484652) na qual afirmou que não há obrigação legal para custeio de medicação, não sendo uma das hipóteses de tratamento na quimioterapia oncológica ou durante internação hospitalar. Requereu a total improcedência da demanda.

Réplica apresentada (ID 140000724).

Intimadas sobre a necessidade de produção de provas, apenas a parte ré apresentou manifestação, quando requereu o julgamento antecipado do litígio.

É o relatório necessário. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito e de fato, mas que dispensa a produção de prova em audiência, dado que as provas trazidas aos autos já são suficientes para o julgamento da causa.

Por inexistirem preliminares ou prejudiciais, passo, de imediato, ao mérito da demanda.

DO MÉRITO

Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela para fins de compelir a empresa demanda a arcar os custos de da medicação semaglutida na dosagem gradativa e crescente de 0,25 mg até 1mg. É fato incontroverso que a autora padece da doença indicada na inicial, bem como os riscos a que se submete.

Cinge-se a lide, unicamente, em verificar a eventual exclusão da cobertura em apólice e eventual existência de danos morais.

Da análise atenta dos autos, verifico que não assiste razão à parte demandante.

Explico.

Sobre o direito material específico em questão, a Lei nº 9.656/98 prevê expressamente a obrigatoriedade de cobertura das doenças listadas na "Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde".

É o que se conclui da leitura de seu artigo 10, *caput* e §2º, que traz o chamado "plano-referência", de cobertura mínima devida a qualquer beneficiário do plano:

> "Art. 10.É instituído o **plano-referência** de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, **compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil**, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, **das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei**, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
>
> § 2º ***As pessoas jurídicas*** que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei ***oferecerão, obrigatoriamente***, a partir de 3 de dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo ***a todos os seus*** atuais e ***futuros consumidores.*** (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001 c/c ADI 1931, STF)"

O plano-referência, de oferta mínima obrigatória por parte das operadoras de planos de saúde, portanto, ressalvadas hipóteses dos incisos do artigo 10, abarca todos os tratamentos das doenças elencadas com CID (Cadastro Internacional de Doenças).

Sendo assim, basta que a parte autora, vinculada ao plano de saúde, junte atestado de profissional da saúde habilitado a tanto demonstrando necessidade de tratamento de doença sofrida pelo consumidor para que tenha direito à cobertura do tratamento.

Portanto, a doença da qual padece o beneficiário do plano de saúde e o respectivo tratamento devem ser atestadas por profissional competente para tanto, de livre escolha do paciente, o que é assegurado pela própria lei 9.656/98 (art. 1º, I) e pela RN 428/ANS (art. 5º).

Especificamente sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos por parte da operadora de plano de saúde, o já mencionado artigo 10 da Lei nº 9.656/98 põe a salvo situações específicas em seus incisos em que a cobertura não é obrigatória por força de lei, sem prejuízo de sua previsão contratual.

É o caso, por exemplo, do custeio de *alguns* tipos de medicamentos, cujo fornecimento não é obrigatório, salvo em casos de doenças específicas, como o câncer, ou que necessitem de administração ambulatorial, sendo que os medicamentos para usodoméstico e osimportados não nacionalizados não são abrangidos pelo plano de referência, nos termos dos seguintes dispositivos da referida legislação:

> "Art. 10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
>
> V - *fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados*;
>
> VI - **fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;** (Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)
>
> Art. 12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas
>
> I - quando incluir atendimento ambulatorial:
>
> c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)
>
> II - quando incluir internação hospitalar:
>
> g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da

assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (...)

Desta feita, *a contrario sensu*, percebe-se que o fornecimento de medicamentos é devido, desde que não se trate de medicamentos importados nacionalizados nem os de uso para tratamento domiciliar, e, ainda, são devidos aqueles fármacos previstos no disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12 da lei 9.656/98, que visem tratamentos de câncer.

Em tempo, segundo a Resolução Normativa nº 167 da ANS, a definição de medicamento domiciliar é: "medicamentos para tratamento domiciliar são aqueles que não requerem administração assistida, ou seja, não necessitam de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado ou cujo uso não é exclusivamente hospitalar, podendo ser adquiridos por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público e administrados em ambiente externo ao de unidade de saúde (hospitais, clínicas, ambulatórios e urgência e emergência)".

No caso ora analisado, o medicamento cujo fornecimento foi pleiteado é de uso doméstico, foi juntado atestado médico confirmando que a autora possui doença, especificando a necessidade de tratamento mediante uso de medicamento, entretanto, a medicação é ministrada em seu domicílio.

Foi juntado laudo (ID 132100528), especificando que a parte autora necessita de: "uso de medicação que favoreça a perda de peso, sem interferências em sua doença base, a saber, o diabetes e o carcinoma de mama."

Concluo que, no caso dos autos, o medicamento requerido pela parte autora não está previsto como exceção dentre as hipóteses legais previstas, não sendo o caso de administração ambulatorial, ou de medicação para o câncer.

Ainda que a parte autora esteja lutando conta a grave doença de carcinoma de mama, o tratamento para a perda de peso consiste em um tratamento paralelo e realizado em âmbito domiciliar, dissociado do tratamento de câncer, conforme restou assentado em laudo médico.

Assim, não havendo necessidade obrigatória de intervenção hospitalar para aplicação do medicamento, nem de qualquer profissional da saúde em ambiente hospitalar, não há obrigatoriedade de cobertura de tal fármaco pelo plano de saúde demandado.

Nesse sentido:

PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE MEDICAMENTO – VALIDADE DA EXCLUSÃO DA COBERTURA – Autora que busca a condenação da ré à obrigação de custeio do medicamento "Ozempic" (Semaglutida) – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Droga prescrita para tratamento de obesidade grau II e pré-diabetes – Medicamento de uso domiciliar, com livre aquisição em farmácia comum e administração injetável pelo próprio paciente – Validade da exclusão contratual de

cobertura, nos termos do art. 10, VI, da Lei 9.656/98 – Orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ – Precedentes, ademais, deste E. TJSP quanto à licitude da recusa de cobertura especificamente quanto ao remédio sub judice – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1029125-61.2021.8.26.0001 São Paulo, Relator: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 23/11/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DIABETES MELLITUS TIPO 1. INDEFERIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DA HIPÓTESE ÀS EXCEÇÕES LEGAIS NEM AOS PRECEDENTES JUDICIAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido para que o plano de saúde agravado forneça medicamentos e equipamento de uso domiciliar para controle de diabetes mellitus tipo 1 (CID: E10), que acomete o agravante há 27 (vinte e sete) anos, não encontra respaldo na legislação nem em precedentes judiciais. 2. O art. 10 da Lei nº 9.656/1998 determina, expressamente, que a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não estaria, a princípio, incluída dentro do plano de referência de assistência à saúde. 3. Na mesma linha segue o Rol de Procedimentos e Eventos da ANS disposto na RN nº 465/2021, salvo os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. 4. Os medicamentos prescritos pelo médico para tratamento da diabetes que acomete o agravante são de uso domiciliar e não se enquadram nas exceções previstas na Resolução 465 da ANS, como os fármacos antineoplásicos. Também não há precedente do STJ que autorize a concessão dos medicamentos e aparelhos vindicados para uso domiciliar. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07096558020238070000 1715006, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 13/06/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/06/2023)

Em que pese nos solidarizarmos com a condição de saúde da parte autora e entender a necessidade de ver realizado o tratamento, não vislumbro a responsabilidade de a operadora de saúde arcar com os custos da medicação requestada.

Nesta ordem de ideias, a improcedência do pedido de custeio do tratamento é medida que se impõe e, considerando a inexistência de negativa indevida, de igual forma, deve ser improcedente os pleitos indenizatórios.

III - DISPOSITIVO

Desse modo, pelo que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da petição inicial e extingo o feito com resolução de mérito.

Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiaria da gratuidade de Justiça.

Ademais, havendo interposição de apelação, em consonância com o art. 1.010 do CPC: (a) intime-se o recorrido para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as devidas contrarrazões (§ 1º); (b) se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (§ 2º); (c) decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem a apresentação das contrarrazões, subam os autos ao Egrégio TJPE, com as homenagens deste Juízo (§ 3º).

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Datado e assinado eletronicamente.

mmm

Assinado eletronicamente por: FABIANA MORAES SILVA
17/12/2023 14:16:29
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 155682791

23121714162934200000152068651

IMPRIMIR GERAR PDF